

Fecha Última Actualización: 15-11-2022 12:52:30

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Margarita Virginia Navarrete Maldonado **Rut** : 6.930.008-1 **N° Archivo** : 0928339
Edad : 70a 4m 7d **Fecha Nacto**: 08/07/1952 **Sexo** : Femenino
Dirección : Buque 2863 Villa Santa Teresa **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 948988127

N° Epicrisis
326847

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utac/ Utinx **Fecha Ingreso** : 28/09/2022 11:49 **Días Estadía**: 48
Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía **Fecha Egreso** : 15/11/2022 12:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Encefalitis Herpética

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Ingreso CASR: 28/09/22
Ingreso UTAC: 30/09/22
Ingreso Recuperación: 01/10/22.
Ingreso UCI: 02/10/22.
Reingreso UTAC: 14/10/22
Ingreso Sala: 16/10/22

ANTECEDENTES:

Diestra, mRs 1

- Mórbidos: Hipertensión arterial sistémica, Resistencia a la insulina, Trastorno de ánimo y duelo reciente.
- Quirúrgicos: Colectomía, 3 cesárea
- Alergias: no refiere
- Familiares: Rotura de aneurisma intracraneano madre, hermano y sobrino. Sin antecedentes de ECJ.
- Hábitos: OH (-), tabaco (-), drogas (-).
- Fármacos de uso habitual: Sertralina, Ciclobenzaprina, Zopiclona, Metformina, Amlodipino, Carvedilol, Valaplex (Valsartán + Hidroclorotiazida), AAS, Clopidogrel.
- Inmunizaciones: 2 dosis anti SARS-COV-2.
- Social: Vive en San Fernando con esposo; escolaridad enseñanza media, dueña de casa.

HISTORIA ACTUAL:

El 18/09 presentó delirios de persecución aparentemente sin confusión asociada. El 23/09 a las 5:00 despertó confusa, agitada, y con idea delirante. Fue llevada a servicio de urgencias en San Fernando donde se le realizó TC de cerebro que habría resultado normal (no se cuenta con imagen ni informe), se administró haloperidol, y fue dada de alta. Evolucionó con deterioro progresivo de cuadro dado por disminución de emisión de lenguaje y desorientación llegando a desconocer a su familia. Al interrogatorio dirigido con sudoración (sin fiebre cuantificada); se desconoce si presentó cefalea, focalidad neurológica o eventos sugerentes de crisis. Fue traída por nieta a Santiago y fue evaluada en extrasistema quién interpretó cuadro como trastorno adaptativo (hermana de paciente con cáncer de reciente diagnóstico) y reemplazó zopiclona por quetiapina. Por persistencia de cuadro finalmente fue traída al servicio de urgencias de nuestro centro el 27/09. Ingresó hipertensa 146/74 mmHg, normocárdica 92 bpm, febril con 37.8°C, normosaturando 95% FiO2 21%. Dentro de exámenes de laboratorio de

Fecha Epicrisis : 15/11/2022 12:52

Página 1 de 5

Fecha Última Actualización: 15-11-2022 12:52:30

Página 2 de 5

ingreso destacó ELP 130/3.3/96, PCR 31, PCR-SARS-COV 2 (-), OC no inflamatoria. Fue hospitalizada en servicio de urgencia para estudio y se mantuvo clopidogrel de uso crónico.

Evolucionó con febrículas y deterioro neurológico llegando al mutismo el 29/09. Se realizó TC de cerebro el que se interpretó sin lesiones agudas, y se solicitó evaluación por neurología. En dicha evaluación destacó mutismo, ausencia de conexión con el examinador y seguimiento de órdenes, hemianopsia derecha, mirada preferente a izquierda, paresia facial central derecha, paresia braquial derecha M3 y M2+ crural derecho, paresia braquiocrural izquierda M4, plantares flexores, temblor postural de EESS. Por sospecha de encefalitis, y ante contraindicación de punción lumbar por uso de clopidogrel, se tomaron hemocultivos y se inició aciclovir de forma empírica. Se complementó ampliamente estudio destacando:

- RM de cerebro con gadolinio (29/09): Hiperseñal en difusión y T2 FLAIR con restricción relativa y leve tumefacción de corteza frontal superior en forma bilateral, giro cingulado anterior izquierdo, giro frontal medio, corteza de giros frontales orbitarias y en menor medida de la ínsula izquierdos, sin desfase de señal en T2 ni refuerzo. Hiperseñal T2 FLAIR de corteza del hemisferio cerebeloso derecho y de sustancia blanca pontina. No se observaron refuerzos patológicos tras la administración del medio de contraste. Principales senos venosos duros permeables. Impresión: Los hallazgos son compatibles con una encefalitis de probable etiología infecciosa viral.
- TC-TAP (29/09): Leve cardiomegalia global. Lesión quística unilocular anexial izquierda sin criterios tomográficos de agresividad. Divertículos en marco colónico, sin signos de complicación actual. Leve ateromatosis cálcica aortoiliaca.
- Laboratorio: VIH NR, VDRL NR.

El mismo día 29/09 evolucionó afebril, con leve mejoría clínica fluctuante (llegando a repetir y seguir órdenes simples), por lo que se inició ácido valproico en dosis de carga 1.2 g. El día 30/09 fue trasladada a UTAC.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

1. Encefalitis en estudio: Sospecha de encefalitis herpética.
2. Sospecha de estado epiléptico no convulsivo.
3. Hiponatremia leve.
4. Antecedentes.

EVOLUCIÓN:

1.- Neurológico:

En UTAC evolucionó en regulares condiciones generales, manteniendo vigilia, pero sin conexión con el entorno. Se añadió levetiracetam a esquema de fármacos antiepilépticos, y se realizó un monitoreo EEG de aproximadamente 15 horas que se informó con estado epiléptico focal de inicio anterior izquierdo, a pesar de uso de LEV y VPA. Por lo anterior se trasladó a unidad de recuperación de forma transitoria para manejar cuadro epiléptico con sedación farmacológica; se realizó IOT sin incidentes, se mantuvo conectada a VMI con sedación SAS 1, y se cargó con fenitoína 1500 mg IV; posteriormente se trasladó a UCI. Se mantuvo con sedación farmacológica, fenitoína, levetiracetam y ácido valproico; en EEG de control del 03/10 se informó frecuente lentitud intermitente anterior derecha (sin actividad epileptiforme), y con ello se decidió retiro gradual de la sedación farmacológica. Se recibió el mismo día niveles plasmáticos indetectables de fenitoína por lo que se decidió suspender, manteniendo LEV 1.5 g cada 12 horas y VPA 500 mg cada 8 horas.

El día 05/10 se realizó punción lumbar tras 7 días de suspensión de Clopidogrel y de tratamiento antiviral, con LCR que resultó sin células, proteínas 0.25, glucosa 58 mg/dL, tinción Gram sin bacterias, cultivo corriente (-), PCR VH1, VH2 y VVZ (-), GeneXpert TBC (-), tinta china negativa, cultivo de Koch pendiente. Finalmente completó 14 días de aciclovir IV en dosis meníngeas. Evolucionó con mejoría paulatina del nivel de conciencia sin clínica sugerente de crisis y sin requerir profundizar sedación; se realizó nuevo EEG de control el 13/10 que informó lentitud del ritmo posterior de base (sin actividad epileptiforme), y niveles de VPA resultaron en 45. Dado evolución favorable se decidió no aumentar dosis de VPA, y se trasladó a UTAC el 14/10. En UTAC se mantuvo sin lograr franca vigilia pero estable, y finalmente se trasladó a sala de neurología el 16/10.

En sala tuvo franca mejoría clínica dada por lograr vigilia persistente, conexión y comunicación, aunque con confusión y signos de desinhibición frontal. Por ausencia de confirmación de etiología del aparente cuadro infeccioso mediante estudio de LCR, se realizó RM de cerebro con gadolinio de control el 20/10 que se informó control de encefalitis con marcada disminución del engrosamiento e hiperseñal cortical previamente descritos. Además se realizó nuevo EEG de control el 24/10 que se informó con ocasional lentitud intermitente frontocentral bilateral sincrónica lateralizada a derecha y lentitud del ritmo posterior de base.

Fecha Epicrisis : 15/11/2022 12:52

Página 2 de 5

Desde el punto de vista de la rehabilitación comenzó a progresar de manera importante en sala de neurología y actualmente logra deambular con carro de marcha y asistencia preventiva por posterior; desde el punto de vista deglutorio inicialmente con disfagia severa FILS 3, con necesidad de SNG para alimentarse, evolucionó con mejoría progresiva, logrando retiro de SNG el 03/11, actualmente con disfagia FILS 8, alimentándose con blando sin granos + líquidos claros. Además en seguimiento por terapia ocupacional con plan de fomentar atención en actividades cotidianas

2.- Respiratorio/ Infectológico:

En UCI se trató 7 días con ampicilina/sulbactam por sospecha de neumonía aspirativa, con respuesta favorable; se extubó sin incidentes el 10/10. Destacó PCR de 51 al alza el 13/10, que se interpretó como secundario a flebitis en antebrazo derecho que se trató con medidas locales sin uso de antibióticos con buena respuesta. En adelante sin nuevas intercorrientes infecciosas. A su llegada a sala se realizó estudio de portación de bacterias resistentes, resultando (+) para *E. faecium* Van B, por lo que se inició aislamiento de contacto. El 20/10 presentó aparente macroaspiración de contenido gástrico durante RM bajo anestesia dado desaturación de O₂, llegando a requerir aporte de O₂ hasta 3 Lt por naricera; se realizó Rx de tórax que no evidenció signos de aspiración ni foco de condensación. Se maneja con KTR, y evolucionó sin requerimientos de O₂ suplementario ni fiebre.

El 27/10 se tomó PCR SARS-COV-2 para traslado a HSJM y resultó (+); clínicamente afebril y sin síntomas respiratorios pero con somnolencia. Evolucionó estable con parámetros inflamatorios en descenso, finalizó aislamiento el 01/11. Actualmente sin clínica respiratoria

3.- Hemodinámico:

Por tendencia a la hipertensión se inició tratamiento antihipertensivo; logró buen control de cifras tensionales con amlodipino 10 mg al día, carvedilol 6,25 mg cada 12 horas, y espironolactona 25 mg al día.

4.- Hidroelectrolítico:

A su ingreso con hiponatremia; posteriormente cursó con hipernatremia con VEC bajo que se resolvió con aporte de ringer lactato IV y agua libre por SNG. El 13/10 presentó hipokalemia de 2.9 por lo que se administró carga IV, y posteriormente requirió nueva carga el 14/10, con buena respuesta. En control de ELP el 28/11 con hipokalemia leve nuevamente en 3.32, se inició aporte oral de KCL con potasio de control del 01/11 en 3.9. Se solicitó último control 02/11 con niveles de potasio 4.3 mEq/L por lo que se suspendió aporte.

5.- Dermatológico:

A su ingreso a sala de neurología se evidenció importante dermatitis en zona del pañal con úlcera lineal grado 2 en cara medial de muslo derecho; se ha manejado con aseo y uso de pasta lassar para prevención de humedad, y ha evolucionado favorablemente. A la fecha con leve eritema, sin lesiones, y aplicando bepanthol. Se mantuvo sonda foley con el propósito de evitar humedad en zona del pañal para promover recuperación de lesiones, que posteriormente dado mejoría de dermatitis se decidió retirar sonda foley el 02/11.

6.- Ginecológico:

En TC-TAP se informó lesión quística unilocular anexial izquierda, sin criterios tomográficos de agresividad; se decidió realizar estudio en diferido por ginecología.

7.- Nutricional:

Durante hospitalización con albumina en 2.4, por lo que se sospechó desnutrición calórico proteica. Fue evaluada por ANI impresionó normal con riesgo de desnutrición, calculó requerimientos diarios a 1800 kcal y 85 grs

Actualmente paciente en condiciones de continuar rehabilitación en Hospitalización domiciliaria

DIAGNÓSTICOS ACTUALES:

1. Probable encefalitis herpética tratada
- Estatus epiléptico no convulsivo resuelto.
2. COVID-19 (+) leve
3. Dermatitis del pañal
4. Obs debilidad de paciente UCI
5. Hipokalemia e hipernatremia leve resueltas.

Fecha Última Actualización: 15-11-2022 12:52:30

Página 4 de 5

6. Flebitis ESD resuelta.
7. Portadora de E. faecium Van B
8. Quiste anexial izquierdo en estudio.
9. Antecedentes: HTA, IR, trastorno de ánimo.

Diagnóstico de Egreso

Encefalitis Obs Infecciosa -
Estatus Epiléptico Focal Recuperado -
Neumonía Asociada a Cuidados de la Salud: NAVM -
Lesión Anexial Izquierda -
Hipokalemia E Hipernatremia Resueltas -
Portadora De E. Faecium Van B -
Hipertensión arterial -
Resistencia A La Insulina -
Dermatitis Del Pañal -
Disfagia Severa Fils 3 En Rehabilitación -
Trastorno De La Marcha En Rehabilitación -
Obs Debilidad De Paciente De Uci -
Covid-19 Leve -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Examen neurológico actual:

- Somnolienta, bradipsíquica, hipofónica, invierte días de semana, desorientada parcialmente en espacio y tiempo, sigue órdenes simples, nomina y repite. Impresiona con desinhibición frontal sin agitación.
- NC: Isocoria reactiva, CV normal por amenaza, OCM impresionan normal, me impresiona sin paresia facial, protruye lengua en línea media.
- Motor: Hipotonía generalizada, impresiona asimetría de fuerzas con mayor debilidad braquial derecha M4-, resto M4.
- Sensitivo: Impresiona sin hipoestesia.

mRs 3

Plan Post Alta

Indicaciones Generales

- Levantar asistida con carro de marcha
- Régimen blando sin granos + líquidos claros hiposódico + suplemento de glucerna oral
- Aseo genital y uso de bepanthol en cada muda.

Rehabilitación

- Kinesioterapia
- Fonoaudiología
- Terapia ocupacional

Fármacos:

- Levetiracetam 1.5 mg cada 12 horas por vo.
- Ácido valproico 500 mg cada 8 horas por vo.
- Amlodipino 10 mg al día por vo.
- Carvedilol 6.25 mg cada 12 horas vo.
- Espironolactona 25 mg al día vo.
- Paracetamol 1 g SOS vo
- Omeprazol 20 mg al día, vo
- Melatonina 3 mg en la noche vía oral

Exámenes:

- Realizar ecografía de partes blandas, solicitar hora en radiología con orden entregada

Controles:

Fecha Epicrisis : 15/11/2022 12:52

Página 4 de 5

Fecha Última Actualización: 15-11-2022 12:52:30

Página 5 de 5

- Control con neurología, solicitar hora en CDT pasillo 8, solicitar hora con esta epicrisis
- Control ambulatorio por ginecología, IC realizada
- IC a cirugía
- Control en su CESFAM para manejo de patologías crónicas y entrega de medicamentos
- Consultar en servicio de urgencias en caso de signos de alarma

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Marianela Morales Leal

Becado/Residente

Amada Marcela Espinosa Maramb

Médico Tratante (Staff)